

América Latina necesita una nueva seguridad social

Gasto, demografía y los instrumentos que faltan

Héctor Villarreal · ITED, Tecnológico de Monterrey

XXXVIII Seminario Regional de Política Fiscal · CEPAL · Santiago, Chile

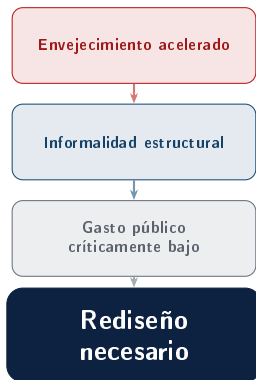
Sesión 4: Gasto e inversión pública para cerrar brechas estructurales · Mayo 2026

El modelo heredado ya no cierra

La seguridad social latinoamericana fue diseñada para economías jóvenes apoyándose en la formalidad.

Ninguna de las dos condiciones se sostiene.

- ▶ La región envejece **antes** de alcanzar el ingreso de los países con estados de bienestar maduros.
- ▶ Informalidad estructural (40–60 %): los sistemas contributivos cubren a **menos de la mitad** de la fuerza laboral.
- ▶ Gasto público en salud **críticamente bajo** en algunos países: México destina 2.6 % del PIB desde el sector público — como si fuera un país de ingreso bajo.
- ▶ El resto es gasto de bolsillo: no planeado, por urgencias. **Regresivo y empobrecedor.**



La trampa de la formalización

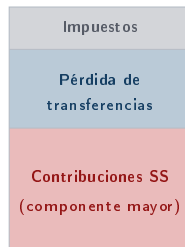
Tasa de Tributación a la Formalización (FTR)

El costo neto de ser formal incluye contribuciones, impuestos y la pérdida de beneficios no contributivos. Si el trabajador no valora lo que recibe, la contribución se percibe como **impuesto puro**.

Diagnóstico regional:

- ▶ El componente más grande del FTR **no son los impuestos**: son las contribuciones a seguridad social.
- ▶ La **valuación** que los trabajadores hacen de esas contribuciones es baja — sistemas opacos, filas largas, confianza débil.

Composición del FTR



Los programas paralelos empeoran la trampa

Al formalizarse, el trabajador enfrenta un costo inmediato y cierto: **pagar cuotas de seguridad social**. Ese es el componente principal del *cliff*.

Además, en muchos países puede perder acceso a programas sociales — aunque esto **no es automático** y depende del diseño de cada programa.

Cliff effect

La combinación de cuotas obligatorias y pérdida potencial de beneficios eleva el FTR precisamente en los trabajadores de ingreso medio-bajo que **podrían** formalizarse.

Costo cierto:

- Cuotas de seguridad social (componente mayor)

Costos posibles:

- Transferencias condicionadas
- Pensión no contributiva
- Acceso a salud gratuita
- Subsidios o becas

Ejemplo: Uruguay eliminó el tope de ingreso formal para acceder a AFAM-PE — reconociendo que el tope desincentivaba la formalización.

Eje 1: Nuevos instrumentos financiero-fiscales para salud

El financiamiento de salud en América Latina depende excesivamente de la nómina formal. Eso lo hace **insuficiente** (pocos contribuyen) e **inequitativo** (los informales quedan fuera o reciben servicios paralelos de menor calidad).

La propuesta no es abandonar la lógica contributiva — es **ampliarla**. Un sistema de salud Bismarckiano donde:

- ▶ Quien puede contribuir, contribuye directamente.
- ▶ Quien no cotiza, paga al menos un **tramo de su prima** — proporcional a su ingreso.
- ▶ El gobierno cubre la prima completa solo para **los más necesitados**. De lo contrario, hay malos incentivos.

Tres instrumentos

- **Cuotas contributivas** rediseñadas — canalizadas a salud, con vínculo claro entre contribución y beneficio
- **Primas graduadas** para no cotizantes — copago proporcional al ingreso; gobierno cubre solo a los más vulnerables
- **Seguros privados de ciclo de vida** — profundan el gasto de salud en la vejez

Tres instrumentos para financiar salud

1. Cuotas contributivas rediseñadas

Canalizadas exclusivamente a salud. Vínculo contribución-beneficio directo y claro.

Que el trabajador perciba **valor**, no impuesto.

2. Primas graduadas para no cotizantes

Copago proporcional al ingreso. El gobierno cubre la prima completa **solo para los más vulnerables**.

No crea un sistema paralelo.

3. Seguros privados de ciclo de vida

Prefondan el gasto de salud de la vejez. Descomprimen el presupuesto público a **largo plazo**.

Lógica Bismarckiana ampliada: todos dentro del sistema de seguros — unos pagando su propia prima, otros con prima pagada por el Estado. Nadie afuera en un esquema paralelo.

Eje 2: Consolidar transferencias en impuesto negativo sobre la renta

La proliferación de programas sociales fragmentados genera el *cliff effect* que vimos: al formalizarse, el trabajador pierde múltiples beneficios de golpe.

La propuesta

Consolidar transferencias en un **impuesto negativo sobre la renta** (IRN).

El beneficio se reduce **gradualmente** conforme el ingreso sube. No hay salto. El trabajador **siempre gana** al formalizarse.

Ventajas: elimina duplicidades administrativas, hace transparente el costo fiscal del piso de protección, y convierte al sistema tributario en **vehículo** de la política social.

Condición necesaria

Mayor observabilidad de ingresos. La digitalización de pagos y facturación electrónica en México, Brasil, Uruguay y Colombia lo hacen factible hoy.

La mecánica del impuesto negativo

Sistema actual:

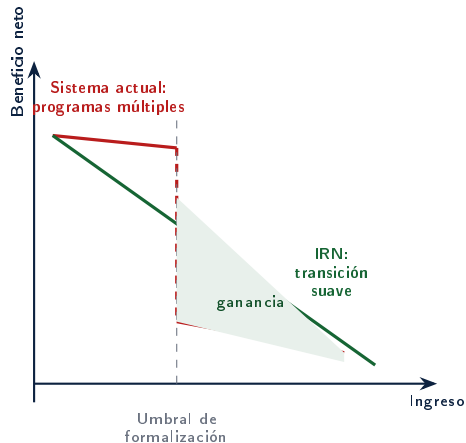
Múltiples programas con umbrales rígidos. Al cruzar el umbral, pérdida abrupta.

Con IRN:

Un solo mecanismo fiscal. El beneficio decrece suavemente. Cada peso adicional de ingreso formal siempre deja al trabajador mejor.

El IRN como puente

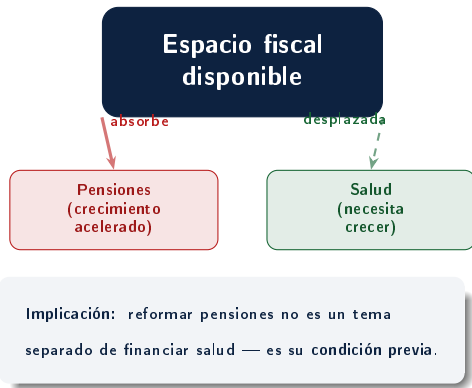
El impuesto negativo facilita la **transición hacia la contribución propia**. No es el destino — es el camino hacia la plena participación en el sistema contributivo.



Sin contención de pensiones, no hay espacio para salud

El gasto en pensiones — contributivas y no contributivas — crece aceleradamente en toda la región.

- ▶ Las promesas previsionales maduraron antes de que la base contributiva se ampliara.
- ▶ Las pensiones no contributivas han sido un **avance importante** en cobertura de adultos mayores. Sin embargo — ya sea como piso focalizado o como beneficio universal — representan un costo fiscal creciente y su diseño puede debilitar el incentivo a cotizar si no se integra con el pilar contributivo.
- ▶ Sin reforma paramétrica, el gasto en pensiones **desplaza** todo lo demás.



La prueba de sostenibilidad fiscal

Cualquier propuesta que dependa de impuestos generales debe demostrar que es **financiable a 20 años**.

Pensiones, salud y cuidados son un solo problema fiscal — compiten por el mismo espacio presupuestario y deben analizarse como sistema, no como silos separados.

Esto requiere análisis explícito de:

- ▶ Dinámica de deuda pública
- ▶ Espacio fiscal real — no el teórico
- ▶ Restricción presupuestaria intertemporal
- ▶ Sensibilidad demográfica

Doble prueba para toda propuesta

1. Sostenibilidad fiscal

¿Se puede financiar a lo largo de la transición demográfica sin generar dinámicas de deuda insostenibles?

2. Incentivos a la formalización

¿Fortalece o debilita el incentivo del trabajador a participar en el sistema contributivo?

Falla en cualquiera de las dos $\Rightarrow$ debilidad estructural.

Una comunidad para esta agenda

¿Cómo pueden los sistemas de salud de América Latina — con sus combinaciones de financiamiento público, contributivo y privado — mantenerse fiscalmente sostenibles e institucionalmente creíbles a través de la transición demográfica y epidemiológica?

Estamos construyendo una **Comunidad Latinoamericana del Conocimiento** sobre Financiamiento de la Salud.

Tríada fundadora:

- ▶ Tecnológico de Monterrey
- ▶ Universidad de los Andes, Colombia
- ▶ Pontificia Universidad Católica de Chile

Una agenda regional sobre los instrumentos que la región necesita.

Seminario inaugural

Septiembre 2026

Escuela de Gobierno y Transformación Pública,
Tecnológico de Monterrey

Agenda

- Instrumentos financieros
- Sostenibilidad fiscal
- Incentivos y formalización
- Economía política de la reforma

*¿Podemos diseñar sistemas de protección social
que la gente valore lo suficiente como para
querer participar — y que los gobiernos puedan
financiar a lo largo de la transición demográfica?*

Si la respuesta es sí, hay que construir los instrumentos.

Héctor Villarreal

hvilillarreal@tec.mx · ITED, Tecnológico de Monterrey